



Doença Inflamatória Intestinal (DII)

Índices de Atividade, Avaliação Clínica e Manifestações

Apostila 3 — Páginas 41–60 · Parte 3 da série sobre DII

GASTROENTEROLOGIA

AValiação Clínica

ÍNDICES DE ATIVIDADE

Índice de Atividade da Doença de Crohn (CDAI)

O **CDAI (Crohn's Disease Activity Index)** é um dos instrumentos mais utilizados internacionalmente para mensurar a atividade da Doença de Crohn, especialmente em ensaios clínicos e pesquisas acadêmicas. Ele é calculado por meio de uma soma ponderada de variáveis clínicas, laboratoriais e subjetivas, oferecendo uma pontuação numérica que orienta decisões terapêuticas.

Variáveis Avaliadas

- Número de evacuações líquidas ou pastosas
- Intensidade da dor abdominal (0–3)
- Estado geral do paciente
- Presença de complicações extraintestinais
- Uso de antidiarreicos
- Achados laboratoriais (hematócrito, peso)

Interpretação da Pontuação

Menor que 150

Remissão — Paciente clinicamente estável

150 a 250

Atividade Leve

250 a 350

Atividade Moderada

Maior que 350

Atividade Grave —
Intervenção urgente necessária

Limitações do CDAI

Apesar de amplamente adotado em estudos clínicos, o CDAI apresenta **limitações metodológicas relevantes** que precisam ser compreendidas por todo profissional que o utiliza na prática clínica. A principal crítica ao índice é sua dependência excessiva de dados subjetivos.



Subestimação da Inflamação

O CDAI pode registrar pontuações baixas (indicando "remissão") enquanto o paciente ainda apresenta inflamação ativa detectável por endoscopia ou marcadores laboratoriais como PCR e calprotectina fecal.



Dependência de Sintomas Subjetivos

Variáveis como "bem-estar geral" e "intensidade da dor" são altamente subjetivas e variam conforme a percepção individual do paciente, introduzindo viés significativo na avaliação.



Dissociação Clínico-Endoscópica

Não há correlação direta entre a pontuação do CDAI e os achados endoscópicos. Um paciente pode parecer clinicamente bem e ainda apresentar lesões mucosas extensas — o que tem implicações diretas no conceito de "remissão profunda".

Ponto clínico essencial: O paciente pode parecer "bem" clinicamente, mas ainda estar inflamado. Por isso, o CDAI jamais deve ser o único parâmetro utilizado para guiar decisões terapêuticas em DII.

Índice Harvey-Bradshaw (HBI)

O **Harvey-Bradshaw Index (HBI)** foi desenvolvido como uma versão simplificada e mais prática do CDAI, dispensando o registro diário de sintomas por 7 dias. É amplamente utilizado na prática clínica ambulatorial por sua facilidade de aplicação e boa correlação com o CDAI.

Parâmetros Avaliados (0–4 cada)

- **Bem-estar geral** — de muito bem a incapacitante
- **Dor abdominal** — de ausente a grave
- **Número de evacuações líquidas** por dia
- **Massa abdominal** — ausente, duvidosa, definida ou definida com sensibilidade
- **Complicações** — artralgia, uveíte, eritema nodoso, etc.

A pontuação final é a soma simples de todos os parâmetros, tornando o cálculo muito mais rápido do que o CDAI.

Interpretação do HBI

≤ 4 pontos

Remissão clínica

5 a 7 pontos

Atividade leve a moderada

≥ 8 pontos

Atividade moderada a grave

O HBI é especialmente útil para monitoramento longitudinal do paciente em consultas de rotina, permitindo acompanhar a evolução da doença de forma objetiva e rápida.

Avaliação Endoscópica na Doença de Crohn

A endoscopia digestiva é uma ferramenta **indispensável** na avaliação da Doença de Crohn. Diferentemente dos índices clínicos, ela permite a visualização direta da mucosa intestinal, identificando lesões em atividade, cicatrização e complicações estruturais. É o padrão-ouro para avaliação da remissão mucosa.



Eritema e Edema

Sinal precoce de inflamação mucosa, com hiperemia e perda do padrão vascular normal. Indica atividade inflamatória mesmo que leve.



Úlceras Aftoides

Pequenas erosões superficiais com halo eritematoso, características dos estágios iniciais da Doença de Crohn. São o achado mais precoce e específico.



Úlceras Profundas e Lineares

Lesões longitudinais profundas que penetram nas camadas submucosa e muscular. Indicam inflamação transmural, característica da Doença de Crohn.



Aspecto em Pedra de Calçamento

Padrão patognomônico da Crohn: resultado da combinação de úlceras lineares com áreas de mucosa preservada e edema submucoso, criando um relevo irregular característico.



Estenoses e Fístulas

Complicações estruturais tardias. Estenoses resultam de fibrose cicatricial; fístulas indicam comunicações anormais entre alças ou entre intestino e outros órgãos.

SES-CD — Índice Endoscópico da Doença de Crohn

O **SES-CD (Simple Endoscopic Score for Crohn's Disease)** é o principal índice utilizado para quantificar a gravidade endoscópica da Doença de Crohn. Ele avalia sistematicamente quatro segmentos intestinais (íleo, cólon direito, cólon transverso e cólon esquerdo/reto), pontuando quatro parâmetros em cada segmento.

Parâmetros Avaliados

- **Tamanho das úlceras** — de ausente (0) a úlceras muito grandes >2 cm (3)
- **Superfície ulcerada** — percentual da superfície com úlceras
- **Superfície afetada** — percentual total do segmento inflamado
- **Presença de estenoses** — transponíveis ou intransponíveis

Cada parâmetro é pontuado de 0 a 3 em cada segmento. A soma total determina a categoria de gravidade.

Interpretação do SES-CD

0 a 2 — Remissão Endoscópica

Mucosa sem lesões ativas.
Meta terapêutica no conceito de "treat to target".

3 a 6 — Atividade Leve

Lesões presentes, mas de pequena extensão e profundidade.

7 a 15 — Atividade Moderada

Lesões extensas, com úlceras de maior tamanho.

Acima de 15 — Atividade Grave

Doença endoscopicamente severa, frequentemente associada a complicações.

Escore de Rutgeerts — Avaliação Pós-operatória

O **Escore de Rutgeerts** é utilizado exclusivamente no contexto pós-operatório da Doença de Crohn, especialmente após ressecção ileocólica. Seu objetivo é quantificar a recidiva endoscópica na anastomose ileocólica, que é o sítio mais frequente de recorrência da doença.

1

i0

Sem lesões na anastomose. **Baixo risco** de recorrência clínica.

2

i1

Menos de 5 lesões aftoides. Risco ainda baixo, monitoramento recomendado.

3

i2

Mais de 5 lesões aftoides ou lesões maiores confinadas à anastomose. **Risco intermediário.**

4

i3–i4

Ileíte difusa com úlceras profundas (i3) ou doença grave com estenose (i4). **Alto risco** de recorrência clínica sintomática.

❏ **Dado clínico crítico:** Estudos mostram que a recidiva endoscópica pós-operatória pode chegar a **100% nos casos graves** (i3–i4) sem terapia de manutenção adequada. A colonoscopia deve ser realizada 6 a 12 meses após a cirurgia para estratificação de risco.

Classificação de Truelove & Witts — Retocolite Ulcerativa

A classificação de **Truelove & Witts** é o instrumento clássico utilizado para estratificar a gravidade de surtos agudos de Retocolite Ulcerativa (RCU). Publicada originalmente em 1955, continua amplamente utilizada por sua praticidade e capacidade de identificar rapidamente pacientes que necessitam de internação ou terapia intensificada.

Surto Leve

Menos de 4 evacuações/dia com ou sem sangue; ausência de sintomas sistêmicos; hemoglobina normal; VHS normal.

Surto Moderado

4 a 6 evacuações/dia; sintomas sistêmicos discretos; anemia leve; VHS elevado.

Surto Grave

Mais de 6 evacuações sanguinolentas/dia; febre >37,8°C; FC >90 bpm; hemoglobina <10,5 g/dL; VHS >30 mm/h. **Internação obrigatória.**

Os critérios avaliados incluem: número de evacuações, presença e volume de sangue nas fezes, frequência cardíaca, temperatura axilar, nível de hemoglobina e Velocidade de Hemossedimentação (VHS). A classificação orienta diretamente a estratégia terapêutica, desde mesalazina oral (leve) até corticoterapia IV e avaliação cirúrgica (grave).

Score de Mayo — Retocolite Ulcerativa

O **Score de Mayo** é o índice mais utilizado mundialmente para avaliar a gravidade da Retocolite Ulcerativa, tanto em contexto clínico quanto em ensaios terapêuticos. Sua grande vantagem é integrar dados clínicos e endoscópicos, oferecendo uma visão mais completa da atividade da doença. A versão completa inclui 4 subescores (frequência evacuatória, sangramento retal, avaliação endoscópica e avaliação médica global), cada um variando de 0 a 3.

Componentes do Score

- **Frequência evacuatória** — comparada ao habitual do paciente
- **Sangramento retal** — de ausente a sangue puro
- **Achados endoscópicos** — de mucosa normal a ulceração espontânea
- **Avaliação médica global** — julgamento clínico do médico

Interpretação da Pontuação

0 a 2 — Remissão

Subscore endoscópico de 0 ou 1 é meta do "treat to target"

3 a 5 — Atividade Leve

Sintomas presentes, mas sem comprometimento sistêmico

6 a 10 — Atividade Moderada

Doença com impacto na qualidade de vida, necessita de escalonamento terapêutico

11 a 12 — Atividade Grave

Endoscopia com ulcerações espontâneas, risco de complicações

Importância da Avaliação Endoscópica — Treat to Target

No paradigma moderno de tratamento da DII, a endoscopia transcende o papel diagnóstico e assume função central no monitoramento terapêutico. O conceito de **"Treat to Target" (T2T)**, recomendado pelas diretrizes ECCO e pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, estabelece metas objetivas de tratamento baseadas em desfechos endoscópicos, não apenas na melhora sintomática.



Avaliação da Resposta Terapêutica

Permite verificar se o tratamento está atingindo a remissão mucosa — meta superior à simples remissão clínica. Pacientes com remissão clínica mas sem remissão mucosa têm maior risco de recaída e hospitalização.



Deteção Precoce de Complicações

Identifica estenoses, fístulas, abscessos e lesões displásicas antes de se tornarem sintomáticas. A vigilância endoscópica é essencial em pacientes com longa duração de doença para detecção de câncer colorretal.



Realização de Biópsias

Permite coleta de material para análise histológica, confirmando atividade inflamatória, grau de cicatrização e rastreamento de displasia. A remissão histológica é considerada a meta mais profunda atualmente.

📌 **Conceito-chave:** No T2T, as metas são definidas prospectivamente: remissão clínica (controle de sintomas) + remissão mucosa (cicatrização endoscópica) + remissão histológica (normalização do infiltrado inflamatório). O ajuste terapêutico deve ser guiado por essas metas, não apenas pelo conforto do paciente.

Manifestações Clínicas da DII — Visão Geral

As **manifestações clínicas da Doença Inflamatória Intestinal** são notavelmente heterogêneas. Não existe um quadro clínico único — a apresentação varia em função do tipo de doença, da localização anatômica, da extensão do acometimento, do grau de atividade inflamatória e da presença ou ausência de complicações. Esse espectro amplo exige do médico uma visão clínica integrativa.

Tipo da Doença

Retocolite Ulcerativa e Doença de Crohn têm perfis clínicos distintos, com diferentes sintomas predominantes, padrões de progressão e risco de complicações específicas.

Localização e Extensão

Na RCU, a localização (proctite, colite esquerda, pancolite) determina a intensidade dos sintomas. Na Crohn, o acometimento pode ser desde o esôfago até o ânus.

Gravidade Inflamatória

Quanto maior a atividade inflamatória, mais intensos os sintomas intestinais e sistêmicos. Surto graves podem cursar com febre, perda ponderal e comprometimento do estado geral.

Presença de Complicações

Complicações como estenoses, fístulas, abscessos e manifestações extraintestinais modificam profundamente o quadro clínico e o prognóstico do paciente.

Quadro Clínico da Retocolite Ulcerativa

A **Retocolite Ulcerativa (RCU)** manifesta-se predominantemente com sintomas intestinais relacionados à inflamação do cólon e reto. O quadro clínico é muitas vezes subagudo ou crônico, com períodos de remissão e exacerbações (surtos). A intensidade dos sintomas correlaciona-se diretamente com a extensão e a gravidade da inflamação colônica.

Sintomas Intestinais Característicos

- **Diarreia com muco e sangue** — principal queixa, podendo ser de alta frequência
- **Hematoquezia** — eliminação de sangue vivo nas fezes
- **Tenesmo retal** — sensação constante de esvaziamento incompleto do reto
- **Urgência evacuatória** — necessidade imperiosa de defecar, com risco de incontinência
- **Dor abdominal** — cólicas em quadrante inferior esquerdo, geralmente aliviadas após evacuação

Manifestações Sistêmicas

- **Perda de peso** — por redução da ingestão alimentar e má absorção
- **Fadiga intensa** — frequentemente associada a anemia ferropriva
- **Febre** — presente nos surtos moderados a graves, pode indicar colite grave ou megacólon
- **Anemia** — por perda crônica de sangue e/ou doença inflamatória crônica

❏ A **urgência evacuatória noturna** é um sinal de alerta para doença moderada a grave e deve sempre ser pesquisada ativamente durante a anamnese.

Diferenças Clínicas Fundamentais: RCU × Crohn

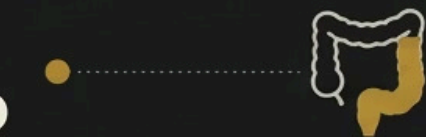
Compreender as **diferenças estruturais e clínicas** entre Retocolite Ulcerativa e Doença de Crohn é essencial para o diagnóstico diferencial e a condução terapêutica adequada. Embora ambas sejam DII, seus padrões de acometimento são fundamentalmente distintos.

RETOCOLITE ULCERATIVA (RCU)

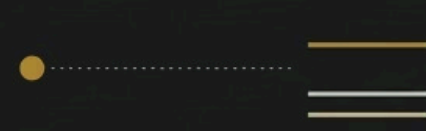
Inflamação Contínua



Acomete Cólon e Reto



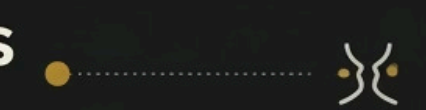
Mucosa e Submucosa



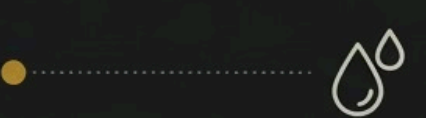
Sem Fístulas



Raras Lesões Perianais



Hemorragia Frequente



DOENÇA DE CROHN

Inflamação Segmentar (Salto de Lesão)



Boca ao Ânus



Inflamação Transmural



Risco de Fístulas/Abscessos



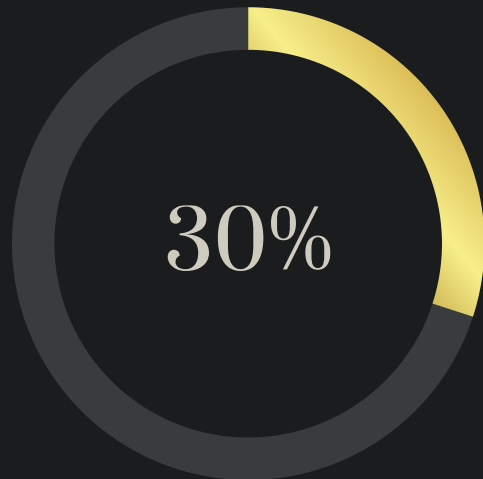
Comum Lesão Perianal (30%)

Dor Abdominal Predominante

A **distribuição contínua** da RCU, sempre iniciando no reto e progredindo proximalmente de forma confluenta, contrasta com o padrão **segmentar e transmural** da Doença de Crohn, que pode afetar qualquer segmento do trato gastrointestinal com áreas de mucosa normal entre as lesões ("skip lesions").

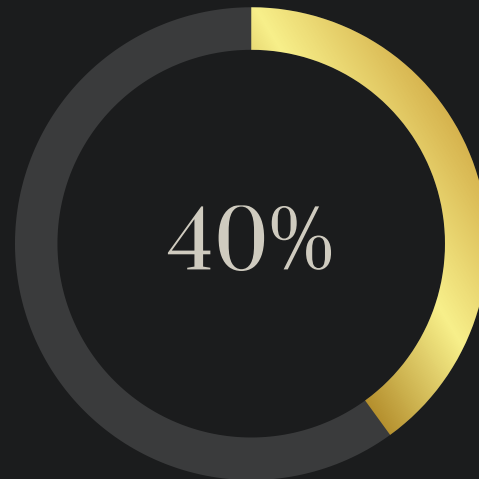
Distribuição e Intensidade da Retocolite Ulcerativa

A **extensão anatômica** da RCU é um dos principais determinantes da gravidade clínica e da estratégia terapêutica. Quanto mais proximal o acometimento, maior a carga inflamatória e mais intensos os sintomas sistêmicos. A classificação de Montreal é a mais utilizada para categorizar a extensão.



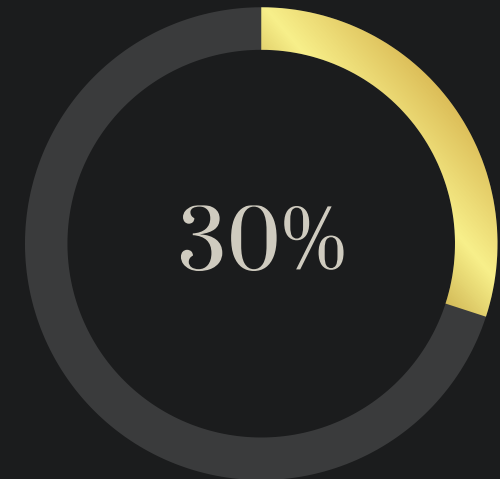
Proctite

Inflamação limitada ao reto. Sintomas predominantes de tenesmo e hematoquezia, frequentemente com diarreia leve. Melhor prognóstico e boa resposta a tratamento tópico.



Colite Esquerda

Acometimento até a flexura esplênica. Sintomas mais intensos, com diarreia, dor em FIE e sangramento. Tratamento combinado tópico e sistêmico.



Pancolite

Inflamação de todo o cólon. Maior risco de surtos graves, complicações (megacólon tóxico) e necessidade de terapia biológica ou cirurgia. Maior risco oncológico.

Os sintomas variam conforme a extensão: na **proctite**, a diarreia pode ser discreta ou até substituída por constipação, com sangramento retal predominante. Na **pancolite**, há diarreia intensa, cólicas difusas, perda de peso significativa, anemia e sintomas sistêmicos como febre e fadiga. A extensão também influencia o risco de câncer colorretal, sendo maior na pancolite após 8-10 anos de doença.

Quadro Clínico da Doença de Crohn

A **Doença de Crohn** apresenta um quadro clínico mais variado e por vezes insidioso do que a RCU, dificultando o diagnóstico precoce. O intervalo médio entre o início dos sintomas e o diagnóstico ainda é de vários anos. Os sintomas dependem da localização predominante da doença — ileocólica (mais comum), ileal, colônica ou gastroduodenal.

Sintomas Principais

- **Dor abdominal crônica** — especialmente em fossa ilíaca direita, simulando apendicite em casos de ileíte terminal
- **Diarreia** — geralmente sem sangue (diferente da RCU), podendo ser volumosa em acometimento ileal por má absorção de sais biliares
- **Perda de peso significativa** — por redução da ingestão, má absorção e estado inflamatório crônico
- **Febre de origem obscura** — pode ser o único sintoma inicial, levando a investigações prolongadas

Achados Clínicos Importantes

- **Massa abdominal palpável (plastrão)** — resultado de aderências entre alças inflamadas, epíplon e outros órgãos. Típico da FID, simula tumor.
- **Lesões perianais** — presentes em até 30% dos pacientes, podendo preceder os sintomas intestinais em anos
- **Manifestações extraintestinais** — artrite, uveíte, eritema nodoso, colangite esclerosante
- **Anemia e hipoalbuminemia** — reflexo da doença crônica e da má nutrição

Manifestações Perianais na Doença de Crohn

As **manifestações perianais** são uma das características mais marcantes e debilitantes da Doença de Crohn, distinguindo-a definitivamente da Retocolite Ulcerativa. Estão presentes em **20 a 40% dos pacientes** e podem surgir antes, durante ou independentemente dos sintomas intestinais. Representam uma das situações clínicas mais desafiadoras no manejo da DII.

1

Plicomas (Tags Perianais)

Dobras cutâneas redundantes ao redor do ânus, frequentemente edemaciadas e dolorosas. São a manifestação mais prevalente e, embora benignas, indicam inflamação perianal ativa. Nunca devem ser confundidas com hemorroidas comuns e não devem ser excisadas sem avaliação multidisciplinar cuidadosa.

2

Fissuras Anais

Diferentemente das fissuras idiopáticas (linha posterior), as fissuras na Crohn são frequentemente múltiplas, em posições atípicas (laterais), indolentes ou com dor crônica intensa, e de difícil cicatrização. Refletem a inflamação transmural característica da doença.

3

Fístulas Perianais

Comunicações anormais entre o canal anal e a pele perianal (ou outros órgãos). Podem ser simples (baixas) ou complexas (altas, envolvendo musculatura do esfíncter). Causam drenagem purulenta, dor crônica e impacto severo na qualidade de vida. São o principal desafio cirúrgico na Crohn perianal.

4

Abscessos Perianais

Coleções purulentas na região perianal, resultado da obstrução das glândulas anais ou da progressão de fístulas. Manifestam-se com dor intensa, febre e abaulamento perianal. São emergências cirúrgicas que requerem drenagem imediata.

Complicações Perianais Graves na Doença de Crohn

As complicações perianais graves representam o espectro mais severo das manifestações perianais da Crohn. Seu manejo requer abordagem **multidisciplinar**, envolvendo gastroenterologista, coloproctologista e, frequentemente, terapia biológica combinada com procedimento cirúrgico. A abordagem isolada (apenas cirúrgica ou apenas clínica) tem resultados inferiores.



Fístulas Enterocutâneas

Comunicações entre o intestino e a pele, frequentemente drenando conteúdo fecal ou purulento. Podem surgir espontaneamente ou como complicação pós-operatória. Exigem identificação precisa por exames de imagem (RNM de pelve) antes de qualquer intervenção cirúrgica.



Fístulas Complexas

Fístulas altas, com múltiplos trajetos, envolvendo o esfíncter externo ou estruturas adjacentes (vagina, bexiga, uretra). A classificação de Parks orienta o planejamento cirúrgico. O tratamento biológico com anti-TNF (infliximabe) é a base terapêutica, com taxas de fechamento de 30–60%.



Abscessos Perianais Extensos

Coleções purulentas profundas, isquiorretais ou supraelevadoras, com risco de sepse. Requerem drenagem cirúrgica de urgência e cobertura antibiótica. A introdução do anti-TNF deve ser precedida obrigatoriamente da drenagem para evitar sepse grave.

 **Protocolo de segurança crítico:** Nunca iniciar terapia biológica (anti-TNF) em presença de abscesso não drenado. O controle cirúrgico do foco séptico é mandatório antes de qualquer imunossupressão.

Avaliação Clínica Completa do Paciente com DII

Nenhum parâmetro isolado — seja clínico, laboratorial, endoscópico ou de imagem — é capaz de definir completamente o quadro de um paciente com DII. A abordagem moderna é fundamentalmente **integrativa e multimodal**, combinando múltiplas ferramentas de avaliação para uma tomada de decisão terapêutica robusta.

Avaliação Clínica

Anamnese detalhada com índices validados (CDAI, HBI, Truelove & Witts, Mayo).
Avaliação da qualidade de vida e impacto funcional.

Exames de Imagem

Enterorressonância magnética e enterotomografia para avaliação de segmentos de difícil acesso endoscópico, estenoses, fístulas e abscessos.



Exames Laboratoriais

Hemograma, PCR, VHS, albumina, calprotectina fecal, lactoferrina. Marcadores não invasivos de inflamação e atividade de doença.

Endoscopia

Avaliação mucosa direta com índices endoscópicos (SES-CD, Mayo endoscópico).
Biópsia para análise histológica e rastreio de displasia.

A integração dessas quatro dimensões permite não apenas definir atividade e gravidade da doença, mas também orientar o escalonamento terapêutico, monitorar resposta ao tratamento, detectar complicações precocemente e estabelecer o momento ideal para intervenções cirúrgicas. Este é o padrão de excelência no cuidado ao paciente com DII.

Resumo Comparativo dos Índices de Atividade

Para uma visão consolidada e prática dos principais índices utilizados na avaliação da DII, a tabela abaixo compara as características essenciais de cada instrumento — facilitando a escolha do índice mais adequado para cada situação clínica.

Índice	Doença	Tipo	Remissão	Grave	Uso Principal
CDAI	Crohn	Clínico/lab	< 150	> 350	Pesquisa clínica
HBI	Crohn	Clínico	≤ 4	≥ 8	Prática clínica
SES-CD	Crohn	Endoscópico	0–2	> 15	Mucosa/T2T
Rutgeerts	Crohn	Endoscópico	i0–i1	i3–i4	Pós-operatório
Truelove & Witts	RCU	Clínico/lab	Leve	Grave	Surto agudo
Mayo Score	RCU	Clínico/endo	0–2	11–12	Clínica e pesquisa

 **Princípio fundamental:** Nenhum índice substitui a avaliação clínica integrativa. Índices clínicos, endoscópicos e laboratoriais são complementares e devem ser utilizados em conjunto para guiar decisões terapêuticas na DII.

Conclusões e Pontos-Chave

Esta apostila consolida o conhecimento essencial sobre **índices de atividade, avaliação clínica e manifestações da DII**. A integração desse conteúdo é fundamental para o manejo de excelência do paciente com doença inflamatória intestinal.

1 Índices Clínicos São Pontos de Partida

CDAI e HBI orientam a avaliação da Doença de Crohn; Truelove & Witts e Mayo guiam a RCU. Porém, todos têm limitações e não devem ser usados isoladamente — a dissociação clínico-endoscópica é real e clinicamente relevante.

3 RCU e Crohn Têm Perfis Clínicos Distintos

Inflamação contínua colônica versus inflamação segmentar transmural em todo o TGI. Essa diferença fundamental orienta diagnóstico, tratamento e vigilância de complicações.

2 A Endoscopia É Insubstituível

SES-CD e Mayo endoscópico definem remissão mucosa — a principal meta terapêutica no conceito de "Treat to Target". A cicatrização mucosa reduz hospitalizações, cirurgias e risco oncológico.

4 Manifestações Perianais São Crohn até Prova em Contrário

Fístulas, abscessos e fissuras atípicas na região perianal devem sempre levantar suspeita de Doença de Crohn. O manejo multidisciplinar (clínico + cirúrgico) é obrigatório e a segurança na introdução de biológicos depende do controle séptico prévio.